Buổi 7 (BẢO VỆ & VIẾT: đạo đức, liêm chính, Phương pháp và Kết quả): Phiếu bài tập

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · Neudata · *#ClearDataClearImpact* · Tuần 7 · Thứ Bảy 12/12/2026 · trực tuyến, 19:30–22:30

Họ và tên: _____ **Khoa/Phòng:** _____

Gõ câu trả lời vào tệp Word này hoặc in bản PDF.

Phần	Bài tập	Khi nào	Cách làm
A	Tình huống liêm chính: xanh, vàng hay đỏ?	20:25 (5 phút)	Cả lớp, bình chọn: 3 tình huống trong lớp, 3 tình huống ở nhà
B	Xây dựng đề cương 7: đạo đức, đăng ký, tính khả thi, kế hoạch công bố	20:30 (15 phút)	Giảng viên làm mẫu với ví dụ xuyên suốt; bạn viết Phần 4 của mình ở nhà
C	**Thực hành bản thảo 1**: phần Kết quả cho câu hỏi FLUID-ICU của bạn	21:35 (45 phút)	30 phút cả lớp làm Q1, rồi 15 phút cho câu hỏi của bạn. Hoàn thành ở nhà

Các tệp bạn cần (gửi qua email): gói kết quả của câu hỏi bạn chọn (`Results_Pack_QN_VN.pdf`), mẫu bản thảo (`Manuscript_Template_IMRaD_VN.docx`), Bài báo 1 (Boulet 2024) và Bài báo 2 (Hyun 2023).

Phần A: Tình huống liêm chính: xanh, vàng hay đỏ? (5 phút, 20:25)

Trên lớp, cả lớp bình chọn cho tình huống 1, 3 và 4; tình huống 2, 5 và 6 là bài về nhà. Với mỗi tình huống, chọn:

- **XANH**: chấp nhận được như mô tả.
- **VÀNG**: chấp nhận được **chỉ khi** sửa hoặc công khai một điều gì đó (nói rõ điều gì).
- **ĐỎ**: hành vi sai trái trong nghiên cứu hoặc vi phạm nghiêm trọng. Không được làm.

Viết một câu giải thích màu bạn chọn.

#	Tình huống	Màu	Vì sao?
1	Phiếu theo dõi dịch ngày 3 của ba người bệnh bị mất. Một bác sĩ nội trú "nhớ đại khái" cân bằng dịch của họ và nhập các giá trị đó để bộ dữ liệu được đầy đủ.		
2	Sau khi xem kết quả, nhóm nghiên cứu loại hai người bệnh có giá trị dịch "lạ" vì họ làm yếu mối liên quan. Bài báo không đề cập việc này.		
3	Trưởng khoa không tham gia nghiên cứu nhưng đề nghị đứng tên tác giả cuối "vì đây là khoa của tôi".		
4	(a) Một điều dưỡng dùng chatbot AI để cải thiện tiếng Anh cho phần Bàn luận do chính cô viết, kiểm tra từng câu, và nêu rõ điều này trong phần Lời cảm ơn. (b) Một đồng nghiệp tải bảng tính của nghiên cứu (có cả họ tên và mã số bệnh viện) lên một chatbot công cộng miễn phí và nhờ nó "chạy thống kê".	(a)	
		(b)	
5	Một nghiên cứu thuần tập trên người bệnh sepsis giống FLUID-ICU được công bố thành ba bài báo (tử vong, tổn thương thận cấp và thời gian nằm ICU) trên ba tạp chí, không bài nào nhắc đến các bài kia.		
6	Hai đoạn văn của một bài tổng quan đã công bố được chép nguyên văn vào phần Đặt vấn đề của bạn. Bài tổng quan được trích dẫn ở cuối đoạn, nhưng không có dấu ngoặc kép.		

Phần B: Xây dựng đề cương 7: đạo đức, đăng ký, tính khả thi và kế hoạch công bố

Trong lớp (20:30, 15 phút): giảng viên điền trực tiếp phiếu này trên màn hình chia sẻ cho ví dụ xuyên suốt (nghiên cứu thuần tập hồi cứu về cân bằng dịch và tử vong 28 ngày ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU của mình). Bạn gợi ý câu trả lời trong khung chat.

Ở nhà trong tuần này: điền phiếu cho đề cương **của riêng bạn**. Phiếu sẽ trở thành Phần 4 của đề cương viết và slide 5 (đạo đức và tính khả thi) và slide 6 (kế hoạch công bố) của bài trình bày. Mọi học viên nộp đề cương viết và 6 slide qua email trước 19:30 thứ Bảy 19/12/2026, Buổi 8 (`Proposal_Brief_VN.pdf`).

B1. Đạo đức và sự đồng ý tham gia

Câu hỏi	Câu trả lời của bạn
Hội đồng đạo đức nào sẽ xét duyệt nghiên cứu? Bạn dự kiến hình thức xét duyệt nào (miễn xét duyệt / xét duyệt rút gọn / xét duyệt đầy đủ)? Hội đồng là bên quyết định.	
Người tham gia là ai, và họ có tự quyết định được khi đủ điều kiện tham gia không?	
Ai đồng ý tham gia (người bệnh / người đại diện hợp pháp / đồng ý trì hoãn / đề nghị miễn đồng ý)? Dùng sơ đồ quyết định về sự đồng ý trong ICU (slide Buổi 7).	
Ai lấy sự đồng ý, khi nào và ở đâu?	
Người tham gia có những nguy cơ và gánh nặng gì, và chúng được giảm thiểu thế nào?	
Nghiên cứu có cần đăng ký không (thử nghiệm: có, trước người bệnh đầu tiên, trên ClinicalTrials.gov hoặc một sổ đăng ký khác của WHO; tổng quan hệ thống: PROSPERO; nghiên cứu quan sát: khuyến khích)?	

B2. Bảo mật thông tin

Câu hỏi	Câu trả lời của bạn
Bạn sẽ thu thập những thông tin định danh trực tiếp nào (nếu có), và vì sao?	
Mỗi người bệnh sẽ được cấp mã nghiên cứu như thế nào?	
Tệp khóa (mã với danh tính) được lưu ở đâu, và ai được mở?	
Dữ liệu đã loại bỏ thông tin định danh sẽ được lưu ở đâu (được cơ sở phê duyệt, có mật khẩu bảo vệ)?	

B3. Kiểm tra tính khả thi (đánh dấu và nhận xét)

✓	Câu hỏi	Nhận xét
☐	**Thời gian:** tiến độ thực tế (hội đồng đạo đức 1–3 tháng, tuyển chọn, phân tích, viết bài)?	
☐	**Kinh phí:** đã nêu các khoản mục ngân sách (thời gian nhân lực, vật tư/xét nghiệm, phí công bố)?	
☐	**Nhân lực:** ai thu thập dữ liệu (ban đêm, cuối tuần), ai phân tích, có thời gian dành riêng không?	
☐	**Người bệnh:** năm ngoái khoa bạn có bao nhiêu người bệnh đủ điều kiện? Bạn có thể tuyển thực tế bao nhiêu người?	
☐	**Dữ liệu:** các biến chính có được ghi nhận thường quy không? Khả năng thiếu bao nhiêu?	

Rủi ro lớn nhất về tính khả thi: _____ Một cách khắc phục: _____

B4. Kế hoạch công bố (slide 6 của bài trình bày)

Mục	Câu trả lời của bạn
Tên đề tài tạm thời (từ PICO: thiết kế, I so với C, P, O; 10–16 từ)	
Tạp chí mục tiêu (và một tạp chí dự phòng), đã kiểm tra trên DOAJ / NLM Catalog, biết rõ phí và giấy phép	
Hướng dẫn báo cáo (CONSORT / STROBE / STARD / PRISMA / SPIRIT / CARE)	
Có cần đăng ký không? Ở đâu? (từ B1)	
Các tác giả (đủ cả bốn tiêu chí ICMJE) và vai trò của họ (CRediT)	
Xung đột lợi ích và nguồn tài trợ cần công bố	
Tuyên bố chia sẻ dữ liệu (chia sẻ gì, ở đâu, với điều kiện gì)	
Hội nghị nơi bạn sẽ trình bày tóm tắt đầu tiên	

Khung tóm tắt có cấu trúc. Mỗi mục một dòng. Phần Kết quả là kết quả bạn *dự kiến sẽ báo cáo* (định dạng, không phải con số).

Mục	Một dòng
Đặt vấn đề	
Phương pháp	
Kết quả (dự kiến)	ví dụ "tử vong 28 ngày: n/N mỗi nhóm, RR (KTC 95%)"
Kết luận	Viết câu bạn sẽ dùng nếu kết quả dương tính, và câu bạn sẽ dùng nếu không.

Phần C: Thực hành bản thảo 1: phần Kết quả (45 phút, 21:35)

Bạn viết **phần Kết quả** cho câu hỏi FLUID-ICU của mình, chỉ dùng gói kết quả của câu hỏi đó. Chỉ bắt buộc nộp phần Kết quả. Bạn có thể thêm các phần khác vào cùng tệp (`Manuscript_Brief_VN.pdf`).

Câu hỏi	Chủ đề	Gói kết quả
Q1	Cân bằng dịch dương đến ngày 3 và tử vong 28 ngày	`Results_Pack_Q1_VN.pdf`
Q2	Cân bằng dịch tích lũy và tổn thương thận cấp (AKI)	`Results_Pack_Q2_VN.pdf`
Q3	Cân bằng dịch tích lũy và số ngày không thở máy	`Results_Pack_Q3_VN.pdf`
Q4	Lactat ban đầu và tử vong 28 ngày, trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội	`Results_Pack_Q4_VN.pdf`
Q5	Cân bằng dịch và thời gian nằm ICU ở người sống sót	`Results_Pack_Q5_VN.pdf`

Cách dùng 45 phút

Giờ	Ai	Việc
21:35–21:45	Cả lớp, Q1	Người tham gia và câu về Bảng 1. Bạn gợi ý câu trong khung chat. Giảng viên gõ câu tốt nhất
21:45–21:57	Cả lớp, Q1	Số tử vong mỗi nhóm, OR thô và hiệu chỉnh kèm KTC 95%
21:57–22:02	Cả lớp, Q1	Các phân tích khác: mô hình Cox và quy gán đa bội
22:02–22:05	Cả lớp	Một học viên đối chiếu mọi con số với gói kết quả
22:05–22:20	Bạn	Bắt đầu phần Kết quả cho câu hỏi CỦA BẠN, theo bản nháp của lớp

Bản nháp của lớp được gửi dạng PDF sau buổi học. Nếu bạn chọn Q1, hãy viết bằng lời của mình.

Danh sách kiểm tra phần Kết quả (mục STROBE)

- ☐ Người tham gia trước: số được thu nhận, được phân tích và bị loại, kèm lý do (13)
- ☐ Bảng 1 trong một hoặc hai câu có số liệu. Có báo cáo dữ liệu thiếu (14)
- ☐ Số kết cục ở mỗi nhóm, kèm mẫu số (15)
- ☐ Kết quả chính: ước lượng **thô và đã hiệu chỉnh** kèm KTC 95% (16)
- ☐ Các phân tích khác trong gói kết quả: độ nhạy, quy gán hoặc phân nhóm (17)
- ☐ Bảng 1 và một bảng hoặc hình chính tự đọc hiểu được
- ☐ Không bình luận ("vì", "gợi ý rằng") và không dùng từ nhân quả
- ☐ Tên bài dự kiến và câu công khai sử dụng AI

Lưu ý riêng cho từng câu hỏi

- **Q3:** số ngày không thở máy phân bố lệch và tính tử vong là 0.
- **Q4:** báo cáo cả ước lượng trường hợp đầy đủ và quy gán đa bội.
- **Q5:** chỉ người sống sót. Dùng trung vị và IQR.

Phương pháp (học ở 7.3, không bắt buộc nộp)

Nếu bạn nộp thêm phần Phương pháp, dùng mục 4 đến 12 của STROBE: thiết kế và bối cảnh, người tham gia, biến số, nguồn dữ liệu, sai lệch, cỡ mẫu ("mọi người bệnh đủ tiêu chuẩn trong nghiên cứu thuần tập đều được đưa vào"), phương pháp thống kê và dữ liệu thiếu. Thông tin có trong gói kết quả, `SAP_FLUID-ICU_VN.pdf` và `Data_Dictionary_VN.pdf`.

Sản phẩm cần nộp

Phần Kết quả của bạn, đặt tên `Surname_Firstname_Results_QN.docx`, gửi email cho người bình duyệt của bạn và giảng viên Vương Mỹ Lượng (myluong1710@gmail.com) **trước 23:59 Chủ nhật 20/12/2026 (giờ Việt Nam)**. Người bình duyệt của bạn được công bố cuối buổi học hôm nay.